PROJET MULTISECTORIEL DE NUTRITION ET DE SANTÉ (PMNS) · PROVINCE DU KWILU · RDC

Services de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) dans la province du Kwilu

Plan de Suivi-Évaluation 2027–2028

Consortium SANRU (chef de file) — ICHESS — FONLIV — FDSS

Maître d'ouvrage	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention (MSPHP)
Bailleur / Unité de gestion	Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé (PMNS) — UG-PDSS
Référence du marché	DP N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS — Formulaire TECH-4
Document source	Tech-4 : approche, méthodologie et programme de travail du Consultant (base unique et exclusive)
Période couverte	Année 1 : janvier – décembre 2027 · Année 2 : janvier – décembre 2028
Version	1.0 — version soumise pour validation
Date de rédaction	Novembre 2026
Auteur	Responsable S&E/HMIS du consortium, avec l'appui d'un expert senior en santé publique et suivi-évaluation

Logo du bailleur : [à confirmer — non disponible dans Tech-4]. Document établi sur la base exclusive du formulaire TECH-4 ; toute donnée absente du document source est signalée par la mention « [À compléter selon Tech-4] ».

Table des matières

Sigles, acronymes et abréviations . . . 4

Résumé exécutif . . . 6

Introduction et contexte . . . 8

5.1 Contexte sanitaire et nutritionnel de la province du Kwilu . . . 9

5.2 Justification du projet . . . 9

5.3 Objectif général et objectifs spécifiques (verbatim TECH-4) . . . 10

5.4 Périmètre, populations bénéficiaires et parties prenantes . . . 10

5.5 Objet, approche et structure du plan . . . 11

Cadre logique du projet . . . 12

6.1 Matrice du cadre logique . . . 13

6.2 Lecture du cadre logique . . . 15

Théorie du changement . . . 16

7.1 Le fondement : le modèle Environnement – Demande – Offre . . . 17

7.2 Chaîne de résultats . . . 17

7.3 Chemin critique et hypothèses . . . 18

7.4 Implications pour le dispositif de suivi-évaluation . . . 18

Système de suivi . . . 19

8.1 Indicateurs de performance . . . 20

8.2 Calendrier de collecte des données . . . 24

8.3 Outils et méthodes de collecte . . . 25

8.4 Flux de données et reporting . . . 26

8.5 Système d'information sanitaire . . . 27

Système d'évaluation . . . 29

9.1 Évaluation à mi-parcours — troisième trimestre 2027 . . . 30

9.2 Évaluation finale — quatrième trimestre 2028 . . . 31

9.3 Évaluations thématiques . . . 31

9.4 Utilisation des résultats . . . 32

Redevabilité et apprentissage . . . 33

10.1 Revues trimestrielles de performance . . . 34

10.2 Réunions de coordination . . . 34

10.3 Capitalisation des leçons apprises . . . 34

10.4 Gestion adaptative . . . 35

10.5 Redevabilité envers les communautés . . . 35

Budget du suivi-évaluation . . . 36

11.1 Enveloppe et répartition par activité . . . 37

11.2 Règles de gestion . . . 37

Annexes . . . 38

Annexe A — Fiches techniques d'indicateurs . . . 39

Annexe B — Modèles de rapports . . . 40

Annexe C — Termes de référence types . . . 41

03

Sigles, acronymes et abréviations

Vocabulaire de référence commun aux deux livrables du dispositif S&E

Les sigles ci-dessous sont ceux employés dans le formulaire TECH-4 et dans le présent plan. Ils constituent le vocabulaire de référence pour l'ensemble des outils de collecte, des rapports et des échanges avec l'UG-PDSS, la DPS du Kwilu et le PRONANUT.

Tableau 1. Sigles et acronymes

Sigle	Signification	Sigle	Signification
AC	Animateur Communautaire	MAS	Malnutrition Aiguë Sévère
AME	Allaitement Maternel Exclusif	MAG	Malnutrition Aiguë Globale
ANJE	Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant	M&E / S&E	Monitoring and Evaluation / Suivi-Évaluation
APA	Autorité Politico-Administrative	MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
AS	Aire de Santé	MNP / MMS	Multi Micronutrient Powder / Supplément Multi Micronutriments
ATPE	Aliments Thérapeutiques Prêts à l'Emploi	MSPHP	Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention
BCP	Bulletin de Performance Communautaire	MUAC / PB	Mid Upper Arm Circumference / Périmètre Brachial
BCZS	Bureau Central de la Zone de Santé	NAC	Nutrition à Assise Communautaire
CAC	Cellule d'Animation Communautaire	OCDE-CAD	Comité d'Aide au Développement de l'OCDE
CAP	Connaissances, Attitudes et Pratiques	ODD	Objectifs de Développement Durable
CCSC	Communication pour le Changement Social et de Comportement	PCIMA	Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aiguë
CODESA	Comité de Développement de l'Aire de Santé	PEC	Prise En Charge
CPN	Consultation Prénatale	PEP	Prophylaxie Post-Exposition
CPoN	Consultation Post-Natale	PFE	Pratiques Familiales Essentielles
CPSr	Consultation Préscolaire Redynamisée	PMNS	Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé
CSU	Couverture Sanitaire Universelle	PNDS	Plan National de Développement Sanitaire
DHIS2	District Health Information Software 2	PRONANUT	Programme National de Nutrition
DPS	Division Provinciale de la Santé	RECO	Relais Communautaire
EAS/HS	Exploitation et Abus Sexuels / Harcèlement Sexuel	S&E	Suivi-Évaluation
ECZS	Équipe Cadre de la Zone de Santé	SMART	Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
EDS	Enquête Démographique et de Santé	SNIS	Système National d'Information Sanitaire
ESP	École de Santé Publique de Kinshasa	SNSAP	Système National de Surveillance Alimentaire et d'Alerte Précoce
FARN	Foyer d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle	SSC	Site de Soins Communautaires
FAF	Fer et Acide Folique	SVS	Survivante de Violence Sexuelle
FEFA	Femme Enceinte et Femme Allaitante	TdR	Termes de Référence
FOSA	Formation Sanitaire	TPM	Third Party Monitoring
HGR	Hôpital Général de Référence	UG-PDSS	Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé
IT	Infirmier Titulaire	UNTA	Unité Nutritionnelle Thérapeutique Ambulatoire
IOV	Indicateur Objectivement Vérifiable	UNTI	Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive
MAA	Monitorage Amélioré pour l'Action	VBG	Violences Basées sur le Genre
MAM	Malnutrition Aiguë Modérée	VAD	Visite À Domicile

04

Résumé exécutif

Ce qu'il faut retenir du dispositif de suivi-évaluation 2027-2028

Le présent Plan de Suivi-Évaluation (S&E) couvre la mise en œuvre des services de Nutrition à Assise Communautaire (NAC) confiée au consortium SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS dans dix zones de santé de la province du Kwilu, sur la période 2027-2028. Il est adossé, sans exception, au formulaire TECH-4 qui constitue sa source unique et exclusive : objectifs, résultats intermédiaires, activités, cibles, zones d'intervention, populations bénéficiaires et parties prenantes y sont repris à l'identique.

Ce que le dispositif doit mesurer. Le projet poursuit un objectif général — s'attaquer aux principaux déterminants du retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans — décliné en quatre objectifs spécifiques (services communautaires, VBG/EAS/HS, participation communautaire, système de santé) et quatorze résultats intermédiaires. Le plan traduit cette architecture en **43 indicateurs** répartis en trois indicateurs d'impact, dix-huit indicateurs de résultat, vingt indicateurs d'extrant et deux indicateurs de processus, chacun doté d'une définition, d'un numérateur et d'un dénominateur, d'une valeur de référence, de cibles annuelles, d'une fréquence, d'une source et d'un responsable nommé.

Comment les données seront produites. Le dispositif articule quatre sources complémentaires : (i) la **collecte de routine** — registres des RECO, cahiers des CAC et CODESA, registres des FOSA, saisie DHIS2 ; (ii) les **enquêtes périodiques** — enquête de référence puis enquêtes SMART, CAP et de fonctionnalité des structures communautaires ; (iii) le **Monitorage Amélioré pour l'Action (MAA)** trimestriel, adossé au cadre des déterminants de la couverture de Tanahashi ; (iv) le **Third Party Monitoring** indépendant et les audits de qualité des données. Ces quatre flux convergent vers le DHIS2 comme plateforme nationale de référence, et vers la DPS du Kwilu et le PRONANUT comme destinataires institutionnels.

Comment les résultats seront utilisés. Le plan organise huit revues trimestrielles de performance, quatre revues semestrielles de la nutrition sous l'égide du Gouverneur et du Ministre provincial de la Santé, une évaluation à mi-parcours au troisième trimestre 2027 et une évaluation finale au quatrième trimestre 2028 conduite selon les six critères du CAD de l'OCDE. Chaque revue se conclut par un plan d'action de redressement daté et attribué, dont la mise en œuvre est elle-même suivie.

Ce que coûtera le dispositif. L'enveloppe de suivi-évaluation est fixée à **7 % du budget total du projet**, conformément à la fourchette de 5 à 10 % recommandée pour les projets financés par des bailleurs internationaux. Sa répartition détaillée par activité figure à la section 11. L'assiette monétaire reste à extraire de Tech-4, qui ne comporte aucune ligne budgétaire chiffrée : elle sera renseignée dès la notification du marché et validée par l'UG-PDSS.

> ▶ **Trois décisions structurantes sont attendues de la partie prenante**
> 1) Validation du présent plan et de son cadre de performance avant le démarrage de la collecte ; 2) Arbitrage sur les cibles marquées (c) — à compléter dès la disponibilité de l'enquête de référence ; 3) Confirmation de l'enveloppe de 7 % et de son assiette budgétaire.

05

Introduction et contexte

Contexte sanitaire, justification, objectifs et périmètre du projet

5.1 Contexte sanitaire et nutritionnel de la province du Kwilu

La malnutrition menace gravement la santé et le développement mondial : elle affecte une personne sur trois sur la planète. En République Démocratique du Congo, la situation demeure préoccupante malgré les efforts consentis au cours des dernières décennies. Le formulaire TECH-4 documente une situation provinciale qui situe le Kwilu systématiquement au-dessus de la moyenne nationale sur les principaux indicateurs nutritionnels.

Près de la moitié des enfants de moins de cinq ans de la province souffrent d'un retard de croissance (47 % contre 42 % au niveau national), 34,8 % présentent une insuffisance pondérale, et seuls 23 % des enfants de 36 à 59 mois atteignent le développement attendu dans au moins trois domaines (lecture-calcul-physique, socio-affectif, apprentissage). Les pratiques d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant sont en retrait : 29,2 % seulement des enfants sont initiés à l'allaitement dans l'heure suivant la naissance (46,9 % au national), 32,7 % bénéficient d'un allaitement maternel exclusif à six mois (53,5 % au national) et 18 % seulement reçoivent une alimentation de complément adéquate en qualité, quantité et fréquence.

Tableau 2. Valeurs de référence du contexte nutritionnel et sanitaire (Kwilu)

Indicateur	Kwilu	National	Source citée dans Tech-4
Retard de croissance (enfants < 5 ans)	47 %	42 %	MICS-Palu 2017-2018
Insuffisance pondérale (enfants < 5 ans)	34,8 %	—	MICS-Palu 2017-2018
Initiation précoce à l'allaitement (< 1 h)	29,2 %	46,9 %	MICS-Palu 2017-2018
Allaitement maternel exclusif à 6 mois	32,7 %	53,5 %	MICS-Palu 2017-2018
Alimentation de complément adéquate (6–23 mois)	18 %	—	MICS-Palu 2017-2018
Femmes enceintes avec au moins 4 CPN	24,3 %	42,9 %	MICS-Palu 2017-2018
Ménages avec point de lavage des mains (eau + savon)	18 %	—	MICS-Palu 2017-2018
Accès à une source améliorée d'eau de boisson	29 %	—	MICS-Palu 2017-2018
Insécurité alimentaire sévère	49,9 %	43,7 %	IPC 2021-2022
Insécurité alimentaire modérée à sévère	67,5 %	65,5 %	IPC 2021-2022
Population vivant avec moins de 1,90 USD par jour	93,2 %	74,7 %	Enquête nationale
Malnutrition aiguë globale (dépistage RECO)	> 8 %	8 %	Rapport DPS/PRONANUT 2020
Couverture des villages en CAC	71 %	—	Cartographie DPS Kwilu 2021
CAC ayant tenu toutes leurs réunions mensuelles	53,6 %	—	DHIS2 2021
CAC disposant d'un plan d'action communautaire	16 %	30 %	PSNSC 2019-2022

Ces déterminants se combinent : mauvaise qualité de l'alimentation, insécurité alimentaire aiguë, prévalences élevées des maladies infantiles (paludisme, diarrhée, infections respiratoires aiguës), épidémies de rougeole et de choléra, conditions d'hygiène dégradées, très faible couverture d'accès à l'eau potable, enfin effets de la situation sécuritaire. La province est par ailleurs la plus peuplée de l'ancienne province du Bandundu, avec une économie essentiellement agricole de subsistance, un élevage peu développé et des zones de production enclavées.

5.2 Justification du projet

Le Kwilu fait partie des neuf provinces les plus touchées par la pauvreté : 93,2 % de la population vit avec moins de 1,90 USD par jour, contre 74,7 % au niveau national. Selon l'IPC 2021-2022, plusieurs de ses zones de santé se trouvent dans une situation nutritionnelle sérieuse. TECH-4 identifie quatre facteurs limitant l'accès, l'utilisation et la qualité des services : l'insuffisance de prestataires communautaires formés en NAC — la dernière formation date de quatre ans et n'a ciblé que la seule zone de santé de Mosango —, l'application isolée ou partielle du paquet d'interventions (PCIMA et ANJE introduites dans Kikwit Nord en

2015, Djuma en 2016, puis les autres zones en 2017-2018), l'absence d'approvisionnement en intrants nutritionnels depuis 2019, et la faiblesse des mécanismes de redevabilité communautaire.

La justification du projet tient donc moins à l'identification de nouveaux besoins qu'à la nécessité de passer d'interventions dispersées à un **paquet complet et intégré** — NAC, PCIMA, ANJE, CPSr — porté simultanément par la communauté et par les formations sanitaires, dans une logique de couverture totale des 3 188 villages et des 250 aires de santé des dix zones ciblées.

5.3 Objectif général et objectifs spécifiques (verbatim TECH-4)

> ★ **Objectif général (citation de TECH-4)**
> « Contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif général du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé (PMNS) qui est celui de s'attaquer aux principaux déterminants du retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans grâce à des actions multisectorielles, complémentaires, ciblées et fondées sur des données probantes et des pratiques éprouvées. »

Tableau 3. Objectifs spécifiques du projet (libellés TECH-4)

Code	Objectif spécifique
OS1	Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (en termes de qualité et de couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé.
OS2	Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste.
OS3	Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires.
OS4	Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et de la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux.

5.4 Périmètre, populations bénéficiaires et parties prenantes

Le projet couvre **dix zones de santé** réparties dans cinq territoires et une ville : Sia (Bagata), Djuma (Bulungu), Gungu, Kingandu (Gungu), Kimputu (Idiofa), Kikwit Nord (Kikwit), Moanza, Mosango, Pay Kongila et Yasa Bonga (Masi-Manimba). La ville de Bandundu, chef-lieu de province, n'abrite aucune des dix zones mais accueille un sous-bureau du consortium pour des raisons stratégiques.

Tableau 4. Répartition géographique des zones de santé ciblées

Territoire	Zone de santé	Aires de santé	Villages	CAC installées	Ménages	RECO attendus
Bagata	Sia	22	129	127	25 751	515
Bulungu	Djuma	35	226	226	50 652	1 013
Gungu	Gungu	31	393	262	58 219	1 164
Gungu	Kingandu	20	222	222	25 320	506
Idiofa	Kimputu	28	237	232	45 962	919
Kikwit	Kikwit Nord	25	833	72	54 506	1 090
Masi-Manimba	Moanza	23	275	273	40 017	800
Masi-Manimba	Mosango	18	250	231	28 247	565
Masi-Manimba	Pay Kongila	23	311	306	35 038	701
Masi-Manimba	Yasa Bonga	25	312	299	51 983	1 040
Total	10 ZS	250	3 188	2 250	415 695	8 314

Populations ciblées. Les cibles directes sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants de moins de cinq ans (avec une attention particulière aux moins de deux ans, dans le cadre des mille premiers jours) et les adolescents. TECH-4 étend explicitement le ciblage aux groupes qui influencent l'état nutritionnel de l'enfant : grands-mères, pères et maris, chefs traditionnels, chefs religieux, guérisseurs traditionnels, RECO et prestataires de soins.

Parties prenantes. La mise en œuvre associe la Division Provinciale de la Santé du Kwilu et le PRONANUT, les dix équipes cadres de zone de santé et leurs bureaux centraux, les 250 CODESA et 10 UCODESA, les 3 188 CAC, les 423 formations sanitaires, l'UG-PDSS et le MSPHP, les partenaires techniques (Fonds mondial / CORDAID / FDSS, UNFPA, PNSR), les clusters Nutrition, WASH et Sécurité alimentaire, une ONG spécialisée dans la prise en charge des VBG, l'École de Santé Publique de Kinshasa, IMA World Health et Save the Children, enfin les autorités politico-administratives, coutumières et religieuses.

5.5 Objet, approche et structure du plan

Le présent document constitue le plan de suivi-évaluation prévu par le résultat intermédiaire 4.5 de TECH-4, qui engage le consortium à élaborer un plan de S&E, à en assurer le suivi périodique par des revues internes, à appuyer la production et le feedback des rapports de terrain et à soumettre les rapports mensuels, trimestriels et annuels à l'UG-PDSS.

Sa construction repose sur quatre partis pris méthodologiques :

1. **Fidélité au document source.** Aucun objectif, résultat, indicateur ou activité n'est introduit s'il ne découle pas directement de TECH-4. Les cibles chiffrées sont celles du document ; à défaut, la mention « [À compléter selon Tech-4] » est employée.
2. **Traçabilité de chaque indicateur.** Chaque indicateur est rattaché à un objectif spécifique et à un résultat intermédiaire identifiés, ce qui permet de reconstituer le chemin entre une donnée de terrain et un engagement contractuel.
3. **Utilité opérationnelle.** Le plan est conçu pour être utilisé par les équipes de zone et les partenaires, non pour être archivé : il privilégie des indicateurs mesurables avec les instruments existants et un calendrier de collecte compatible avec les routines du SNIS.
4. **Redevabilité et apprentissage.** Le dispositif organise la restitution des résultats aux communautés et aux autorités, conformément au principe de redevabilité posé par TECH-4, et la capitalisation systématique des leçons apprises.

Le plan s'organise en douze sections : la présente introduction ; le cadre logique (section 6) ; la théorie du changement (section 7) ; le système de suivi (section 8) ; le système d'évaluation (section 9) ; les mécanismes de redevabilité et d'apprentissage (section 10) ; le budget du S&E (section 11) ; les annexes techniques (section 12). Le **Cadre de Performance** constitue le second livrable : il en est la declinaison opérationnelle et synthétique, destinée au pilotage trimestriel.

06

Cadre logique du projet

Matrice de la chaîne de résultats, indicateurs, sources de vérification et hypothèses

6.1 Matrice du cadre logique

Le formulaire TECH-4 annonce un cadre logique dont la matrice n'est pas reproduite dans le corps du document. Le cadre logique ci-dessous est donc **reconstruit** à partir des objectifs spécifiques, des quatorze résultats intermédiaires et des cibles chiffrées qui y figurent. Chaque énoncé est une reprise de TECH-4 ; les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) renvoient aux fiches de la section 8.1.

Tableau 5. Cadre logique du projet — matrice reconstruite à partir de TECH-4

Niveau d'intervention	Énoncé (TECH-4)	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses / Risques
Impact	Réduction du retard de croissance et de la mortalité liée à la malnutrition chez les enfants de moins de deux ans dans la province du Kwilu (objectif général du PMNS).	I-01 Prévalence du retard de croissance (0–59 mois) : 47 % → tendance à la baisse I-02 Prévalence de l'insuffisance pondérale : 34,8 % I-03 Prévalence de la MAG : > 8 %	Enquêtes SMART ; EDS-MICS ; DHIS2/SNSAP ; rapports PRONANUT	Stabilité macro-économique et sécuritaire ; absence de choc nutritionnel majeur ; contribution attribuable au projet et non mesurée isolément
Effet — OS1	Accès, utilisation et qualité améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé dans les 250 aires de santé des 10 ZS.	R-01 Taux de prise en charge des MAS référés ≥ 80 % R-02 30 FARN fonctionnels P-01 8 314 RECO formés P-04 3 188 CAC fonctionnelles	Registres communautaires ; DHIS2 ; MAA ; rapports de supervision ; enquête de référence	Les communautés adhèrent aux services ; les RECO restent en poste ; les intrants sont disponibles
Produit — RI 1.1	Accès et utilisation améliorés d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé grâce à la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires des 10 ZS ciblées.	P-01 RECO formés (4 956 puis 8 314) P-20 VAD réalisées X-01 Villages couverts par une CAC : 71 % → 100 %	Fiches de présence ; cahiers RECO ; tablettes ODK ; DHIS2	Les villages restent accessibles ; les RECO disposent de vélos et d'outils
Produit — RI 1.2	Mise en place et documentation des approches innovantes pour renforcer la lutte durable contre la malnutrition aiguë (PB-Famille, FARN, modèle IMA/SANRU).	R-02 30 FARN opérationnels dans 30 villages (Yasa Bonga, Kingandu) R-05 Alimentation de complément adéquate	Rapports FARN ; fiches de suivi anthropométrique ; documentation des innovations	Les aliments locaux 4 étoiles sont disponibles ; les mères adhèrent aux démonstrations culinaires
Produit — RI 1.3	Qualité améliorée de l'ensemble des services communautaires : prestataires formés, sites dotés, stocks disponibles, mesures de prévention des infections appliquées.	P-06 423 FOSA dotées R-14 FOSA sans rupture d'intrants P-16 supervisions et accompagnements (4 020/an)	Bons de livraison ; fiches de stock ; rapports de supervision formative ; MAA	La chaîne d'approvisionnement fonctionne ; les superviseurs sont recrutés à temps
Effet — OS2	Communautés sensibilisées et système de prestation de services de prise en charge des survivantes de violences sexuelles et sexistes renforcé dans les 10 ZS.	R-10 Survivantes avec PEC holistique : 1,9 % → ≥ 50 % R-11 10 ZS rapportant des cas VBG P-13 10 comités locaux actifs	DHIS2 ; registres VBG ; rapports de l'ONG spécialisée ; sous-cluster VBG	Les survivantes osent dénoncer ; la confidentialité est garantie ; les kits PEP sont disponibles
Produit — RI 2.1	Comités locaux de lutte contre les VBG/EAS/HS mis en place et actifs dans les 10 ZS.	P-13 Nombre de comités actifs (10) Nombre de réunions trimestrielles tenues	PV de réunion ; arrêtés de mise en place ; rapports de comités	Les autorités politico-administratives soutiennent les comités
Produit — RI 2.2	Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG.	P-11 2 500 jeunes pairs-éducateurs formés Nombre de séances de sensibilisation et d'émissions radio	Rapports d'activité ; rapports de monitorage des radios ; enquête CAP	Les normes sociales évoluent ; les leaders sont engagés

Niveau d'intervention	Énoncé (TECH-4)	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses / Risques
Produit — RI 2.3	Système de prestation de services de prise en charge des survivantes de violences sexuelles renforcé.	P-12 60 formateurs et prestataires formés P-14 6 FOSA dotées en kits PEP Système de référencement fonctionnel dans chaque ZS	Rapports de formation ; fiches de stock PEP ; fiches de référencement	Le référencement est rapide et sécurisé ; les ONG partenaires assurent les volets psychosocial et juridique
Effet — OS3	Structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA) organisées, fonctionnelles et dotées d'un leadership local renforcé dans les 10 ZS.	P-04 3 188 CAC P-05 250 CODESA et 10 UCODESA R-12 CAC tenant leurs réunions mensuelles R-13 CAC avec plan d'action	Cartographie DPS ; DHIS2 ; plans d'action communautaires ; BCP	Les chefs de village exercent leur leadership ; les indemnités de performance sont payées
Produit — RI 3.1	Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés.	R-12 Proportion de CAC fonctionnelles Taux de tenue des réunions de monitorage (CAC, CODESA, UCODESA)	Canevas de monitorage ; rapports CODESA ; MAA	Les membres des CAC sont disponibles et formés
Produit — RI 3.2	Leadership et capacités managériales locales des structures de participation communautaire renforcés.	R-13 CAC disposant d'un plan d'action : 16 % → 30 % Nombre de sessions de renforcement des capacités	Plans d'action communautaires ; rapports de formation ; BCP	Les plans sont réellement mis en œuvre et suivis
Produit — RI 3.3	Coordination, collaboration multisectorielle et mécanismes de suivi des interventions renforcés.	Nombre de réunions de cadre de concertation tenues P-17 40 sessions de MAA par an	Comptes rendus de réunion ; rapports de revues ; bulletins trimestriels	Les partenaires participent régulièrement ; les décisions sont suivies d'effet
Effet — OS4	Offre, utilisation et qualité des services de nutrition améliorées dans les 423 formations sanitaires des 10 ZS, conformément aux normes et standards nationaux.	R-15 FOSA avec personnel formé PCIMA : 27 % → 100 % R-06 Femmes avec ≥ 4 CPN : 24,3 % → 42,9 % R-16 Taux de fréquentation CPSr	DHIS2 ; registres FOSA ; MAA ; évaluations de qualité des soins	Les prestataires restent en poste ; les FOSA appliquent la tarification forfaitaire
Produit — RI 4.1	Offre et utilisation des services de nutrition dans les 423 FOSA des 10 ZS améliorées (PCIMA, CPSr, CPN/CPoN, ANJE).	P-06 423 FOSA dotées P-19 5 076 démonstrations culinaires/an R-07 100 % des femmes avec ≥ 90 comprimés FAF	Registres UNTA/UNTI, CPSr et CPN ; DHIS2 ; rapports de supervision	Les intrants sont disponibles en continu ; les femmes fréquentent les services
Produit — RI 4.2	Qualité des services de nutrition dans les 423 FOSA améliorée (compétences, infrastructures, gestion des intrants).	P-02 846 prestataires formés P-07 10 UNTI réhabilitées et 250 dépôts aménagés R-14 FOSA sans rupture	Rapports de formation ; PV de réception des travaux ; fiches de stock	Les travaux sont réalisés dans les délais ; les marchés sont passés à temps
Produit — RI 4.3	Suivi et coordination des interventions nutritionnelles à tous les niveaux du système de santé renforcés.	P-18 20 sites sentinelles fonctionnels Nombre de revues provinciales et zonales tenues	Bulletins SNSAP ; rapports de revues ; comptes rendus de cluster	Les données circulent de la périphérie vers la province
Produit — RI 4.4	Mise en œuvre des activités de nutrition dans les 10 ZS de la province du Kwilu assurée (bureaux, personnel, logistique).	Taux d'exécution du plan de travail annuel Taux de couverture des 10 ZS par les visites de coordination (180/an)	Rapports d'avancement ; plan de travail annuel ; rapports de mission	Le financement est décaissé à temps
Produit — RI 4.5	Système de suivi-évaluation, de redevabilité et d'apprentissage des activités de nutrition dans les 10 ZS assuré.	X-02 100 % des rapports périodiques transmis à temps P-17 40 sessions de MAA/an 43 indicateurs renseignés	Plan de S&E ; rapports mensuels, trimestriels et annuels ; rapports d'évaluation	Les équipes S&E sont dotées ; les partenaires transmettent leurs données

6.2 Lecture du cadre logique

La matrice se lit de bas en haut : les produits (quatorze résultats intermédiaires) conditionnent les quatre effets (objectifs spécifiques), qui concourent ensemble à l'impact. Trois points méritent l'attention du lecteur.

- **L'impact n'est pas mesuré en attribution mais en contribution.** TECH-4 précise que l'impact du projet ne sera pas analysé au cours de l'évaluation finale, une étude plus approfondie étant nécessaire. Les indicateurs d'impact sont donc suivis en tendance, à partir des enquêtes SMART et du SNSAP, et non rattachés à une cible contractuelle.
- **Deux niveaux d'effets sont mesurés simultanément.** L'objectif spécifique 1 (services communautaires) et l'objectif spécifique 4 (formations sanitaires) portent la même ambition de couverture ; leur enchaînement — la communauté dépiste et réfère, la FOSA confirme et traite — constitue le principal mécanisme causal du projet et doit être suivi comme tel.
- **Les hypothèses sont vérifiables.** Chaque hypothèse de la colonne de droite correspond à un risque documenté dans la matrice de risques du Cadre de performance, avec un indicateur d'alerte précoce associé.

Ce que le cadre logique permet de décider. La matrice n'est pas un document d'archive : elle sert de grille de lecture à trois moments du cycle de gestion. En **revue trimestrielle**, elle permet de distinguer un retard de produit — une formation non réalisée, une dotation non livrée — d'un retard d'effet, qui se manifeste plus tard et relève d'une autre réponse. En **évaluation à mi-parcours**, elle fournit la trame des questions évaluatives : chaque hypothèse de la dernière colonne devient une question à tester sur le terrain. En **évaluation finale**, elle constitue la référence pour apprécier l'efficacité, puisque chaque énoncé de résultat y est associé à des indicateurs et à des sources de vérification explicitement identifiés.

Deux précautions d'usage méritent d'être rappelées. D'une part, la colonne des hypothèses ne se lit pas comme une liste de vœux : chaque hypothèse est associée à un risque documenté et à un indicateur d'alerte précoce, ce qui permet de savoir *quand* l'hypothèse cesse de tenir. D'autre part, le cadre logique ne dit rien des délais : c'est le chronogramme de la section 8.2 qui porte la dimension temporelle, et les deux documents doivent être lus ensemble lors des revues.

07

Théorie du changement

Du modèle EDO de TECH-4 à la chaîne de résultats du projet

7.1 Le fondement : le modèle Environnement – Demande – Offre

TECH-4 inscrit explicitement sa théorie du changement dans le **modèle EDO**. Ce modèle représente de manière égale, équivalente et interdépendante trois domaines : l'**Offre** de services, la génération de la **Demande** et l'**Environnement favorable**. Son postulat est qu'aucun de ces domaines ne peut, à lui seul, produire un changement durable de l'état nutritionnel : c'est leur combinaison qui le permet.

La traduction opérationnelle de ce modèle dans le projet est la suivante : l'Offre est portée par les 3 188 CAC, les 190 sites de soins communautaires et les 423 formations sanitaires ; la Demande est générée par la communication pour le changement social et de comportement, les visites à domicile, les groupes de soutien à l'ANJE et les démonstrations culinaires ; l'Environnement favorable repose sur les structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA), la coordination multisectorielle, les mécanismes de redevabilité et la gestion des risques, y compris les VBG.

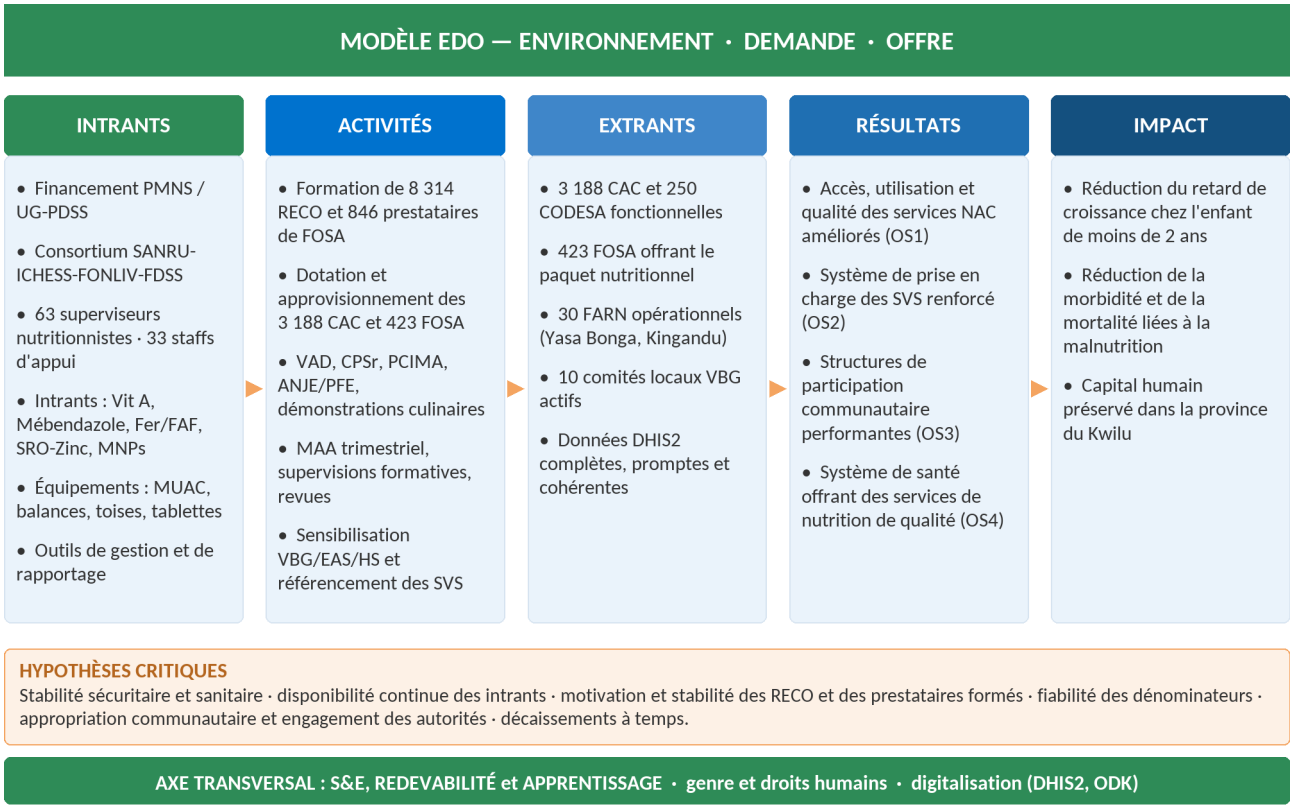


Figure 1. Théorie du changement du projet — chaîne Intrants → Activités → Extrants → Résultats → Impact, adossée au modèle EDO de TECH-4

7.2 Chaîne de résultats

Intrants. Le projet mobilise le financement du PMNS via l'UG-PDSS, le consortium SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS, 63 superviseurs nutritionnistes et 33 personnels d'appui, les intrants nutritionnels (vitamine A, Mébendazole, fer et acide folique, SRO-Zinc, suppléments multi-micronutriments), les équipements de mesure (MUAC, balances, toises), les tablettes et les outils de gestion.

Activités. TECH-4 organise l'essentiel autour de la formation (8 314 RECO, 846 prestataires de FOSA, 60 cadres d'ECZS, 30 formateurs et 30 prestataires en prise en charge des VBG, 2 500 jeunes pairs-éducateurs), de la dotation et de l'approvisionnement des 3 188 CAC, 190 sites de soins communautaires et 423 formations sanitaires, des activités de promotion et de prévention (VAD, CPSr, ANJE/PFE, démonstrations

culinaires, supplémentation, déparasitage), du monitorage et de la supervision.

Extrants. Les extrants attendus sont fonctionnels : des CAC et des CODESA qui fonctionnent, des formations sanitaires qui offrent le paquet nutritionnel complet, trente FARN opérationnels, dix comités locaux de lutte contre les VBG actifs, des données DHIS2 complètes et promptes.

Résultats. Les quatre résultats attendus correspondent aux quatre objectifs spécifiques : accès, utilisation et qualité des services communautaires améliorés ; système de prise en charge des survivantes renforcé ; structures de participation communautaire performantes ; système de santé offrant des services de nutrition de qualité.

Impact. La réduction du retard de croissance chez l'enfant de moins de deux ans, la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la malnutrition et, en dernière instance, la préservation du capital humain de la province.

7.3 Chemin critique et hypothèses

La théorie du changement n'est valide que si quatre conditions se tiennent. Le plan de S&E les traite comme des hypothèses à tester, chacune dotée d'un indicateur d'alerte précoce dans le Cadre de performance.

- **Condition de disponibilité.** Les intrants doivent être présents en continu. TECH-4 signale qu'aucune zone de santé du Kwilu n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019 ; la rupture de stock est donc le risque numéro un, et sa surveillance un indicateur de processus prioritaire.
- **Condition de compétence et de stabilité.** Les compétences acquises lors des formations ne produisent d'effet que si les prestataires restent en poste. TECH-4 prévoit à cet effet une clause de stabilité de deux ans négociée dans la convention entre la DPS et le PMNS.
- **Condition d'adhésion communautaire.** L'utilisation des services dépend de la confiance des ménages et du statut accordé aux femmes. Les normes sociales, les interdits alimentaires et le faible pouvoir de décision des femmes sont identifiés par TECH-4 comme des déterminants majeurs.
- **Condition de qualité de la donnée.** Un dispositif de mesure ne vaut que par la fiabilité de ses données. TECH-4 documente une qualité de données non optimale en termes de complétude, de promptitude et de cohérence, et cinq zones de santé restées « silencieuses » en 2021.

7.4 Implications pour le dispositif de suivi-évaluation

Trois conséquences découlent de cette théorie du changement pour le plan de S&E. Premièrement, le dispositif doit mesurer **les trois domaines du modèle EDO** et pas seulement l'offre de services : d'où l'inclusion d'indicateurs de demande (allaitement, alimentation de complément, fréquentation des services) et d'environnement favorable (fonctionnalité des CAC, plans d'action communautaires, comités VBG). Deuxièmement, il doit mesurer **le lien** entre communauté et formation sanitaire — le taux de prise en charge effective des enfants référés en est l'indicateur pivot. Troisièmement, il doit produire une **information utilisable localement** : c'est la raison d'être du MAA trimestriel et des Bulletins de Performance Communautaire.

08

Système de suivi

Indicateurs, calendrier de collecte, outils, flux de données et système d'information

8.1 Indicateurs de performance

La matrice ci-dessous constitue le cœur opérationnel du plan. Elle comporte **43 indicateurs** répartis selon quatre niveaux : impact (3), résultat (18), extrant (20) et processus (2). Chaque indicateur est rattaché à un objectif spécifique et à un résultat intermédiaire de TECH-4.

> ⚠ **Convention de lecture des cibles**
> Aucune cible n'est indiquée sans mention de son origine. Une cible **sans marque** est une cible explicitement chiffrée dans TECH-4. Une cible suivie de **(b)** est une cible d'alignement sur la référence nationale citée dans TECH-4 : la cible de l'année 2 reprend la valeur nationale, celle de l'année 1 correspond au point médian entre la référence provinciale et cette valeur. Une cible suivie de **(c)**, ou la mention « [À compléter selon Tech-4] », signale une donnée absente du document source : elle sera fixée lors de l'atelier de cadrage de janvier 2027, sur la base de l'enquête de référence.

Tableau 6. Matrice des indicateurs de performance du projet (43 indicateurs)

N°	Indicateur	Type	Définition	Numérateur / Dénominateur	Valeur de référence	Cible Y1 (2027)	Cible Y2 (2028)	Fréquence	Source de données	Responsable
1	Prévalence du retard de croissance chez les enfants de 0–59 mois	Impact	Proportion d'enfants de 0–59 mois dont le z-score taille-pour-âge est inférieur à −2 écarts-types, désagrégée par sexe et par ZS	Enfants 0–59 mois avec T/A < −2 ET / Enfants 0–59 mois mesurés	47 % (MICS-Palu 2017-2018, Kwilu)	Suivi de tendance (c)	Suivi de tendance (c)	Annuelle	Enquêtes SMART ; EDS-MICS	Resp. S&E/HMIS
2	Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 0–59 mois	Impact	Proportion d'enfants de 0–59 mois dont le z-score poids-pour-âge est inférieur à −2 écarts-types	Enfants 0–59 mois avec P/A < −2 ET / Enfants 0–59 mois pesés	34,8 % (MICS-Palu 2017-2018, Kwilu)	Suivi de tendance (c)	Suivi de tendance (c)	Annuelle	Enquêtes SMART	Resp. S&E/HMIS
3	Prévalence de la malnutrition aiguë globale chez les enfants de 6–59 mois	Impact	Proportion d'enfants de 6–59 mois présentant un périmètre brachial < 125 mm ou des œdèmes bilatéraux	Enfants 6–59 mois PB < 125 mm ou œdèmes / Enfants 6–59 mois dépistés	> 8 % (Yasa Bonga 42 % ; Kingandu 18,6 %)	Suivi de tendance (c)	Suivi de tendance (c)	Trimestrielle	DHIS2 ; registres de dépistage ; SMART	Spécialiste Nutrition
4	Taux de prise en charge des enfants MAS référés dans les UNTA/UNTI	Résultat	Proportion d'enfants de 6–59 mois référés pour MAS admis et traités selon le protocole national en vigueur	Enfants MAS référés et admis / Enfants MAS référés	n.d. — à établir par l'enquête de référence (c)	≥ 80 %	≥ 80 %	Trimestrielle	Registres UNTA/UNTI ; DHIS2 ; MAA	Spécialiste Nutrition
5	Dispositif FARN opérationnel dans les villages pilotes	Résultat	Nombre de FARN fonctionnels assurant la réhabilitation des enfants MAM à base d'aliments locaux (ZS Yasa Bonga et Kingandu)	FARN fonctionnels / 30 FARN prévus	0 (dispositif inexistant)	30 (100 %)	30 maintenus	Trimestrielle	Rapports FARN ; supervision ; MAA	Spécialiste Nutrition
6	Taux d'allaitement maternel exclusif chez les enfants de 0–5 mois	Résultat	Proportion d'enfants de 0–5 mois exclusivement allaités au cours des 24 heures précédant l'enquête	Enfants 0–5 mois allaités exclusivement / Enfants 0–5 mois	32,7 % (contre 53,5 % au national)	43 % (b)	53,5 % (b)	Annuelle	Enquête CAP ; SMART ; DHIS2	Resp. S&E/HMIS
7	Taux d'initiation précoce de l'allaitement (dans l'heure suivant la naissance)	Résultat	Proportion d'enfants de moins de 24 mois mis au sein dans l'heure suivant l'accouchement	Enfants mis au sein < 1 heure / Enfants de moins de 24 mois	29,2 % (contre 46,9 % au national)	38 % (b)	46,9 % (b)	Annuelle	Enquête CAP ; DHIS2 (CPoN)	Resp. S&E/HMIS

N°	Indicateur	Type	Définition	Numérateur / Dénominateur	Valeur de référence	Cible Y1 (2027)	Cible Y2 (2028)	Fréquence	Source de données	Responsable
8	Proportion d'enfants de 6–23 mois recevant une alimentation de complément adéquate	Résultat	Proportion d'enfants de 6–23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément suffisante en qualité, quantité et fréquence	Enfants 6–23 mois avec alimentation adéquate / Enfants 6–23 mois	18 %	À compléter (c)	À compléter (c)	Annuelle	Enquête CAP ; MAA	Spécialiste Nutrition
9	Proportion de femmes enceintes ayant bénéficié d'au moins 4 consultations prénatales	Résultat	Proportion de femmes enceintes ayant achevé au moins 4 CPN au cours de la grossesse	Femmes avec ≥ 4 CPN / Femmes enceintes attendues	24,3 % (contre 42,9 % au national)	33,6 % (b)	42,9 % (b)	Trimestrielle	DHIS2 ; registres CPN	Spécialiste Nutrition
10	Proportion de femmes enceintes ayant reçu au moins 90 comprimés de fer et acide folique	Résultat	Proportion de femmes enceintes ayant reçu la totalité de la cure de 90 comprimés de FAF durant la grossesse	Femmes avec ≥ 90 comprimés FAF / Femmes enceintes ayant achevé la grossesse	n.d. — à établir par l'enquête de référence (c)	100 %	100 %	Trimestrielle	Registres CPN ; DHIS2 ; MAA	Spécialiste Nutrition
11	Proportion de femmes ayant effectué leur première CPN avant la 16e semaine	Résultat	Proportion de femmes enceintes dont la CPN 1 est réalisée avant la 16e semaine d'aménorrhée	Femmes avec CPN 1 < 16 SA / Femmes enceintes attendues	n.d. — à établir par l'enquête de référence (c)	80 %	80 %	Trimestrielle	Registres CPN ; DHIS2	Spécialiste Nutrition
12	Proportion de ménages disposant d'un point de lavage des mains avec eau et savon	Résultat	Proportion de ménages visités disposant d'une installation fonctionnelle de lavage des mains (eau + savon)	Ménages avec dispositif eau + savon / Ménages visités	18 %	À compléter (c)	À compléter (c)	Annuelle	Enquête CAP ; VAD ; MAA	Spécialiste engagement communautaire
13	Proportion de survivantes de VBG ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	Résultat	Proportion de survivantes déclarées ayant accédé à une prise en charge médicale, psychosociale et juridique	Survivantes avec PEC holistique / Survivantes déclarées	1,9 % (T3 2021)	25 % (b)	≥ 50 % (b)	Trimestrielle	DHIS2 ; registre VBG ; ONG spécialisée	Spécialiste engagement communautaire / genre
14	Nombre de zones de santé rapportant au moins un cas de VBG dans DHIS2	Résultat	Nombre de ZS sur 10 transmettant des données VBG non nulles (les ZS « silencieuses » en 2021 étaient Kimputu, Moanza, Pay Kongila et Sia)	ZS avec ≥ 1 cas rapporté / 10 ZS	6 ZS sur 10	10 ZS	10 ZS	Trimestrielle	DHIS2 ; rapport PNSR	Resp. S&E/HMIS
15	Proportion de CAC tenant leurs réunions mensuelles de monitorage	Résultat	Proportion de CAC ayant tenu les douze réunions mensuelles de l'année, telle que rapportée dans DHIS2	CAC avec 12 réunions tenues / CAC fonctionnelles	53,6 % (2021)	À compléter (c)	À compléter (c)	Trimestrielle	DHIS2 ; canevas CAC ; BCP	Spécialiste engagement communautaire
16	Proportion de CAC disposant d'un plan d'action communautaire	Résultat	Proportion de CAC dotées d'un plan d'action communautaire élaboré et mis en œuvre	CAC avec plan d'action / CAC fonctionnelles	16 % (contre 30 % au niveau national)	23 % (b)	30 % (b)	Semestrielle	Plans d'action CAC ; CODESA ; MAA	Spécialiste engagement communautaire
17	Proportion de FOSA sans rupture de stock d'intrants nutritionnels	Résultat	Proportion de FOSA n'ayant enregistré aucune rupture de Vitamine A, Mébendazole, FAF, SRO-Zinc ou MNP durant le trimestre	FOSA sans rupture / FOSA appuyées (423)	0 % — aucune ZS approvisionnée en intrants depuis 2019	100 %	100 %	Trimestrielle	Fiches de stock ; rapports BCZS ; MAA	Spécialiste marchés publics et logistique
18	Disponibilité de personnel formé à la PCIMA dans les FOSA	Résultat	Proportion de FOSA disposant d'au moins un prestataire actif formé à la PCIMA au cours des 24 derniers mois	FOSA avec ≥ 1 prestataire formé PCIMA / 423 FOSA	27 % (MAA 2016)	100 %	100 %	Semestrielle	Fiches de formation ; MAA ; supervision	Spécialiste Nutrition
19	Taux de fréquentation de la Consultation Préscolaire redynamisée	Résultat	Rapport entre les nouvelles consultations préscolaires et les enfants de 0–59 mois attendus	Nouvelles CPSr / Enfants 0–59 mois attendus	40,3 % (moyenne provinciale)	À compléter (c)	À compléter (c)	Trimestrielle	DHIS2 ; registres CPSr	Spécialiste Nutrition

N°	Indicateur	Type	Définition	Numérateur / Dénominateur	Valeur de référence	Cible Y1 (2027)	Cible Y2 (2028)	Fréquence	Source de données	Responsable
20	Taux de satisfaction des bénéficiaires à l'égard des services de nutrition	Résultat	Proportion d'usagers déclarant être satisfaits de la qualité et de l'accueil des services reçus	Usagers satisfaits / Usagers interrogés	n.d. — enquête de référence (c)	À compléter (c)	À compléter (c)	Annuelle	Enquête de satisfaction ; BCP	Resp. S&E/HMIS
21	Nombre de RECO formés au paquet NAC	Extrant	Nombre cumulé de relais communautaires ayant achevé la formation ou le recyclage au paquet NAC (ANJE, PCIMA, CPSr, PFE, VBG, gestion des données)	Fiches de présence et attestations / cible 8 314	0 (dernière formation : ZS Mosango, il y a 4 ans)	4 956	8 314	Trimestrielle	Rapports de formation ; base RH communautaire	Spécialiste Nutrition
22	Nombre de prestataires de FOSA formés au paquet nutritionnel	Extrant	Nombre cumulé de prestataires des 423 FOSA formés ou recyclés (PCIMA, CPSr, ANJE, PFE, gestion des intrants)	Prestataires formés / cible 846 (2 par FOSA)	0	846	846 (recyclage)	Semestrielle	Rapports de formation ; DPS	Spécialiste Nutrition
23	Nombre de cadres d'ECZS formés	Extrant	Nombre cumulé de membres d'ECZS formés (MCZS, MDH, DN, nutritionniste, AC, IS) soit 6 par ECZS	Cadres formés / cible 60	0	60	60 (recyclage)	Annuelle	Rapports de formation	Spécialiste Nutrition
24	Nombre de CAC mises en place ou redynamisées	Extrant	Nombre cumulé de cellules d'animation communautaire fonctionnelles dans les 3 188 villages des 10 ZS	CAC redynamisées / 3 188 villages	2 250 (71 %)	3 188 (100 %)	3 188 maintenues	Trimestrielle	Cartographie DPS ; rapports CODESA ; DHIS2	Spécialiste engagement communautaire
25	Nombre de CODESA et d'UCODESA fonctionnels	Extrant	Nombre de comités de développement d'aire de santé et d'unions de comités fonctionnels	CODESA fonctionnels / 250 ; UCODESA / 10	250 CODESA (100 %) ; 10 UCODESA	250 / 10	250 / 10	Trimestrielle	Rapports CODESA /UCODESA ; MAA	Spécialiste engagement communautaire
26	Nombre de FOSA dotées en équipements, matériels et intrants	Extrant	Nombre de FOSA ayant reçu le paquet d'équipements (balances, toises, MUAC, dispositifs de lavage) et les intrants nutritionnels	FOSA dotées / 423	0	423	423 (renouvellement)	Semestrielle	Bons de livraison ; PV de réception	Spécialiste marchés publics et logistique
27	Nombre d'UNTI réhabilitées et de dépôts aménagés	Extrant	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques intensives réhabilitées et de dépôts d'intrants aménagés	UNTI / 10 ; dépôts / 250	0	10 UNTI / 250 dépôts	Maintenance	Semestrielle	Rapports de travaux ; PV de réception	Spécialiste marchés publics et logistique
28	Nombre d'émissions radio de sensibilisation nutritionnelle diffusées	Extrant	Nombre d'émissions diffusées dans les 10 ZS sur l'ANJE, l'EHA et les VBG	Émissions diffusées / 150	0	150	Poursuite selon plan de communication	Trimestrielle	Rapports de monitorage des radios	Chef de projet
29	Nombre de spots conçus et diffusés	Extrant	Nombre de spots de sensibilisation traduits dans les langues locales et diffusés	Spots diffusés / 10	0	10	10 maintenus	Semestrielle	Contrats de diffusion ; rapports	Chef de projet
30	Nombre d'écoles appuyées pour les jardins scolaires	Extrant	Nombre d'écoles appuyées (semences, matériel aratoire, formation pratique) dans les 10 ZS	Écoles appuyées / 30	0	30	30 maintenues	Annuelle	Conventions écoles ; rapports	Spécialiste Nutrition
31	Nombre de jeunes pairs-éducateurs formés en VBG/EAS/HS	Extrant	Nombre cumulé de jeunes pairs-éducateurs formés et intégrés aux CAC	Pairs-éducateurs formés / 2 500	0	2 500	Recyclage	Semestrielle	Rapports de formation	Spécialiste engagement communautaire / genre

N°	Indicateur	Type	Définition	Numérateur / Dénominateur	Valeur de référence	Cible Y1 (2027)	Cible Y2 (2028)	Fréquence	Source de données	Responsable
32	Nombre de formateurs et de prestataires formés à la prise en charge médicale des VBG	Extrant	Nombre de formateurs provinciaux (30) et de prestataires cliniques (30) formés ou recyclés à la PEC médicale des VBG/EAS/HS	Formés / 60	0	60	Recyclage des 8 ZS ; formation initiale des 2 ZS restantes	Semestrielle	Rapports de formation	Chef de projet
33	Nombre de comités locaux de lutte contre les VBG mis en place et actifs	Extrant	Nombre de comités locaux opérationnels, dotés d'un plan de travail et réunis au moins une fois par trimestre	Comités actifs / 10 ZS	0	10	10	Trimestrielle	PV de réunion ; rapports de comités	Spécialiste engagement communautaire / genre
34	Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques VBG	Extrant	Nombre de FOSA des ZS non appuyées par le Fonds mondial (Kimputu, Gungu) dotées en kits PEP	FOSA dotées / 6	0	6	Réapprovisionnement	Semestrielle	Bons de livraison ; rapports de stock	Spécialiste marchés publics et logistique
35	Nombre de FOSA connectées directement au DHIS2	Extrant	Nombre de FOSA des AS de Kikwit Nord et Mosango dotées d'un kit informatique, solaire et d'un accès internet	FOSA connectées / 42	0	42	42 maintenues	Semestrielle	Rapports IT ; DHIS2	Responsable IT
36	Nombre de supervisions conjointes et d'accompagnements réalisés	Extrant	Nombre de supervisions DPS/PRONANUT (60), ECZS (180), visites de coordination (180) et accompagnements des nutritionnistes (3 600)	Missions réalisées / 4 020/an	0	4 020	4 020	Mensuelle	Rapports de supervision ; canevas ECZS	Spécialiste Nutrition
37	Nombre de sessions de Monitorage Amélioré pour l'Action organisées	Extrant	Nombre de sessions de MAA tenues au niveau communautaire, du centre de santé et de la ZS	Sessions tenues / 40 par an (4 × 10 ZS)	0	40	40	Trimestrielle	Rapports MAA ; DHIS2	Resp. S&E/HMIS
38	Nombre de sites sentinelles du SNSAP fonctionnels	Extrant	Nombre de sites sentinelles transmettant mensuellement leurs données nutritionnelles à la DPS/PRONANUT	Sites fonctionnels / 20 (2 par ZS)	20 sites installés, transmission discontinue	20	20	Mensuelle	Bulletins SNSAP ; DPS	Resp. S&E/HMIS
39	Nombre de démonstrations culinaires réalisées dans les FOSA	Extrant	Nombre de démonstrations culinaires à base d'aliments locaux organisées (au moins une par FOSA et par mois)	Démonstrations réalisées / 5 076 par an	0	5 076	5 076	Trimestrielle	Rapports FOSA ; supervision	Spécialiste Nutrition
40	Nombre de visites à domicile réalisées par les RECO	Extrant	Nombre de VAD réalisées auprès des enfants de 0–23 mois, des femmes enceintes et des femmes allaitantes	VAD réalisées / nombre de VAD planifiées	n.d. — à établir par le dénombrement (c)	À compléter (c)	À compléter (c)	Mensuelle	Cahiers RECO ; tablettes ODK ; DHIS2	Spécialiste engagement communautaire
41	Proportion de villages couverts par une CAC fonctionnelle	Processus	Proportion de villages des 10 ZS disposant d'une CAC installée et fonctionnelle	Villages avec CAC / 3 188 villages	71 % (2 250 / 3 188)	100 %	100 %	Trimestrielle	Cartographie DPS ; DHIS2	Spécialiste engagement communautaire
42	Proportion de rapports périodiques transmis dans les délais à l'UG-PDSS	Processus	Rapports mensuels, trimestriels et annuels soumis dans les délais contractuels	Rapports transmis à temps / Rapports attendus	n.d.	100 %	100 %	Trimestrielle	Registre des transmissions ; UG-PDSS	Chef de projet
43	Taux de complétude et de promptitude des données DHIS2 des 10 ZS	Processus	Proportion de rapports mensuels attendus effectivement saisis et validés dans DHIS2 dans les délais	Rapports saisis à temps / Rapports attendus	n.d. — 5 ZS « silencieuses » en 2021	À compléter (c)	≥ 90 % (c)	Mensuelle	DHIS2 ; audits de qualité des données	Resp. S&E/HMIS

Les cellules marquées (b) renvoient à la convention d'alignement sur la référence nationale ; les cellules marquées (c) et les mentions « [À compléter selon Tech-4] » signalent une donnée absente du document source. Le détail des 43 indicateurs — y compris les indicateurs de produit non repris ici pour raison de lisibilité — figure dans la base de données de suivi du consortium, dont la structure est décrite à la section 8.5.

8.1.2 Règles de désagrégation

Toutes les données de routine sont désagrégées selon quatre dimensions : le **sexe**, l'**âge** (0–5 mois, 6–23 mois, 24–59 mois, 5–14 ans, 15–19 ans, 20–49 ans), la **zone de santé** et, lorsque la donnée le permet, l'**aire de santé**. Cette désagrégation est une exigence du principe d'équité posé par TECH-4 et une condition de l'analyse des inégalités prévue par l'évaluation à mi-parcours.

8.1.3 Répartition par niveau et par objectif

Tableau 7. Répartition des indicateurs par niveau

Niveau	Nombre	Rattachement	Plage de codes	Fréquence dominante
Impact	3	Objectif général du PMNS	I-01 à I-03	Annuelle
Résultat	18	OS1 (6) — OS2 (3) — OS3 (3) — OS4 (6)	R-01 à R-17	Trimestrielle
Extrant	20	RI 1.1 à 4.5	P-01 à P-20	Trimestrielle
Processus	2	RI 4.5 et pilotage	X-01 à X-03	Mensuelle

8.2 Calendrier de collecte des données

Le calendrier ci-dessous couvre les 24 mois de mise en œuvre. Il articule la collecte continue (routine communautaire et FOSA), les opérations d'assurance qualité (MAA, audits, TPM, supervisions), les temps d'analyse et de redevabilité (revues, bulletins) et les trois moments d'évaluation — référence, mi-parcours, finale.

Tableau 8. Les trois cycles de collecte et leurs responsabilités

Cycle	Périodicité	Sources et instruments	Responsable
Collecte de routine	Mensuelle et trimestrielle	Registres RECO et FOSA, fiches de VAD, tablette ODK, DHIS2 ; consolidation par les IT et les BCZS	RECO, prestataires FOSA, ECZS
Assurance qualité	Trimestrielle (MAA), semestrielle (audits), annuelle (TPM)	Grilles de monitorage amélioré pour action, audits de complétude et de cohérence, visites TPM	Responsable S&E/HMIS, conseillers de zone
Évaluation	Trois temps : référence (T1 2027), mi-parcours (T3 2027), finale (T4 2028)	Enquêtes SMART et CAP, évaluations thématiques, évaluation finale externe	Équipe S&E, évaluateurs externes

Les trois cycles ne se substituent pas les uns aux autres : la routine fournit la mesure continue, l'assurance qualité en établit la fiabilité, l'évaluation en produit le jugement. Un indicateur dont la valeur de routine n'a pas été auditée reste une donnée déclarative ; c'est pourquoi le rapport trimestriel distingue toujours les valeurs vérifiées des valeurs provisoires.

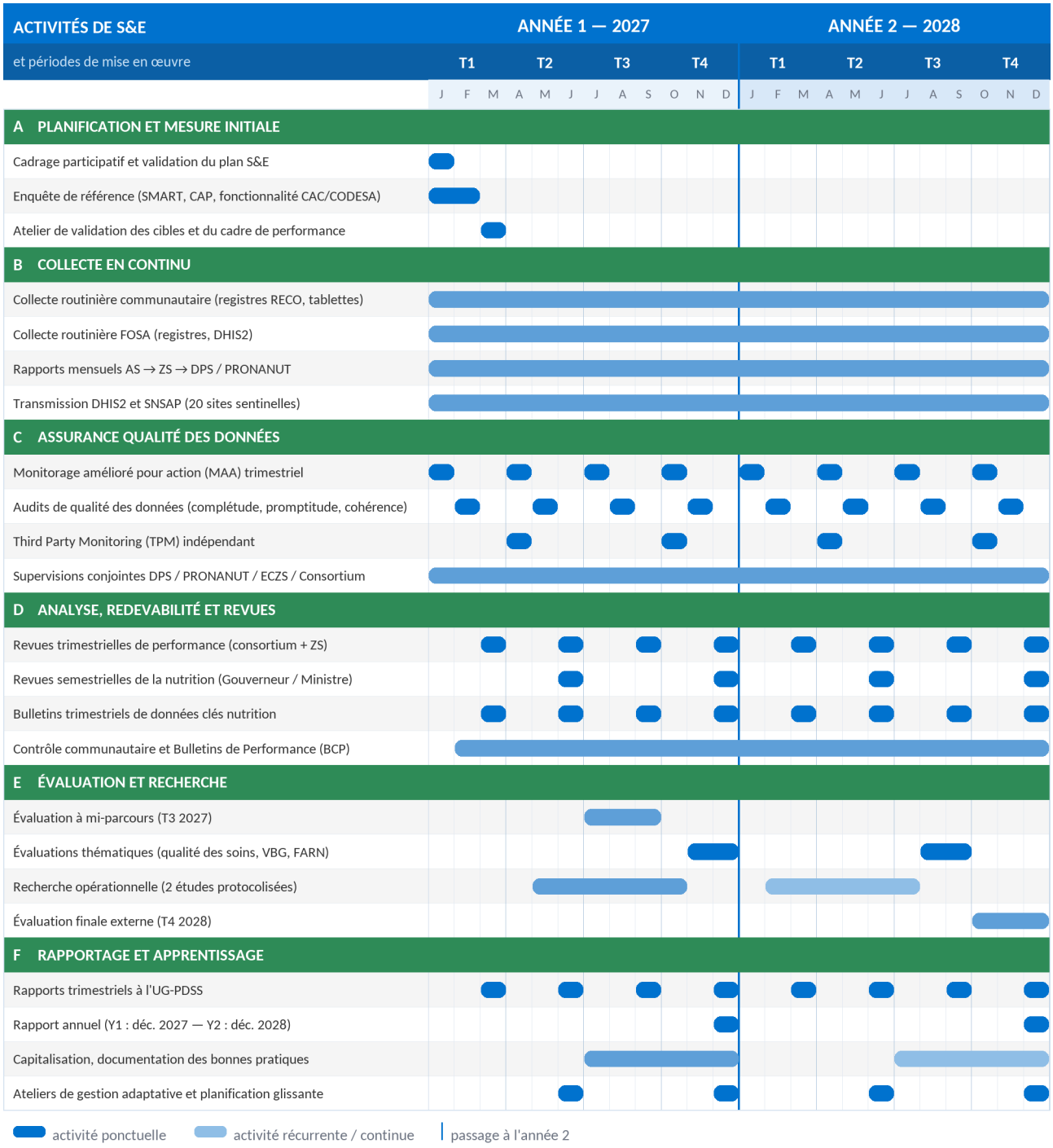


Figure 2. Chronogramme du suivi-évaluation sur 24 mois (janvier 2027 – décembre 2028)

Points de rendez-vous non négociables. L'enquête de référence doit être achevée au plus tard à la fin mars 2027, faute de quoi les cibles ne pourront pas être validées avant le premier trimestre plein. L'évaluation à mi-parcours se déroule sur le troisième trimestre 2027 et son rapport est disponible en octobre 2027, à temps pour l'arbitrage budgétaire de l'année 2. L'évaluation finale s'achève avec le rapport final en décembre 2028.

8.3 Outils et méthodes de collecte

TECH-4 prévoit un dispositif de collecte à quatre étages. Le plan en précise les instruments et les responsabilités.

Tableau 9. Outils et méthodes de collecte

Dispositif	Instruments	Acteurs	Périodicité	Couverture
Collecte de routine communautaire	Cahier du RECO, registre de VAD, registre de dénombrement, fiche de référence, tablettes électroniques (ODK)	RECO, supervisé par les AC et les IT	Mensuelle	3 188 CAC, 8 314 RECO
Collecte de routine en formation sanitaire	Registres UNTA/UNTI, fiche de croissance CPSr, registre CPSr, registre CPN, fiches de stock	Prestataires, IT, nutritionnistes des BCZS	Mensuelle	423 FOSA
Monitorage Amélioré pour l'Action	Canevas MAA adossé au cadre de Tanahashi (disponibilité, accessibilité, utilisation, qualité)	ECZS, AC du consortium, communautés	Trimestrielle	10 ZS, 250 AS
Enquêtes périodiques	Questionnaires SMART, CAP, fonctionnalité des structures communautaires, qualité des services	Équipe S&E, enquêteurs formés, ESP Kinshasa	Référence, mi-parcours, finale	Échantillon représentatif par ZS
Third Party Monitoring	Grille d'audit indépendante, vérification croisée des données RECO et des enquêtes ad hoc	Opérateur indépendant	Semestrielle	Échantillon aléatoire de villages et de FOSA
Audits de qualité des données	Grille de vérification complétude / promptitude / cohérence appliquée au DHIS2	Resp. S&E/HMIS, responsable IT	Trimestrielle	10 ZS, 42 FOSA connectées
Supervision formative	Canevas de supervision NAC et FOSA, formulaire d'observation de VAD, formulaire d'évaluation de cas, spot check ménages	Superviseurs nutritionnistes (63), ECZS, DPS/PRONANUT	Mensuelle / trimestrielle	4 020 missions par an
Contrôle communautaire	Bulletin de Performance Communautaire (BCP), registre de plaintes	CAC, CODESA, communautés	Trimestrielle	3 188 villages
Évaluations de la qualité des soins	Grille « Quality Health Scaling », auto-évaluation des centres nutritionnels	DPS, ECZS, consortium	Semestrielle	423 FOSA, 10 UNTI

● Règle des trois sources

Aucun indicateur de résultat n'est renseigné à partir d'une source unique. Le principe retenu est la triangulation : donnée de routine (DHIS2) + observation directe (MAA, supervision) + mesure indépendante (enquête ou TPM). Un écart supérieur à 10 points de pourcentage entre deux sources déclenche une vérification documentée.

8.4 Flux de données et reporting

Le flux de données du projet suit la pyramide sanitaire de la RDC. Il est représenté ci-dessous, de la communauté vers le niveau national, avec la boucle de rétroaction qui conditionne l'utilisation des données sur le terrain.

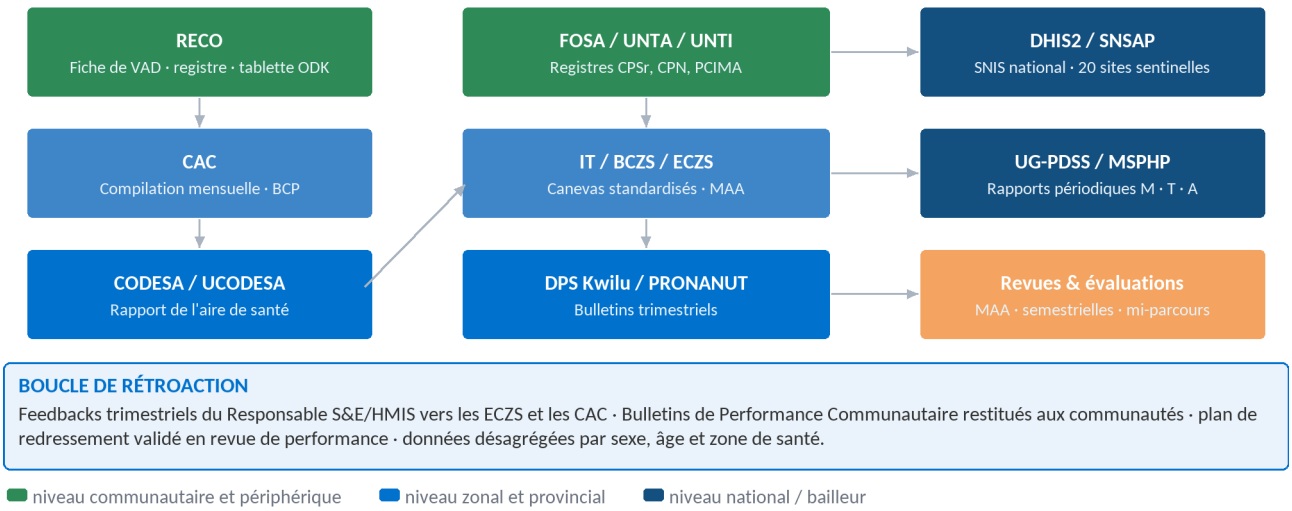


Figure 3. Flux de données et circuit de reporting, du RECO au niveau national

Tableau 10. Responsabilités dans le flux de données

Émetteur	Objet transmis	Destinataire	Fréquence	Point de contrôle qualité
RECO	Fiche de VAD, registre de dénombrement	CAC / CODESA	Mensuelle	Exhaustivité des ménages suivis
CAC / CODESA / UCODESA	Canevas de compilation, BCP	IT / BCZS	Mensuelle	Tenue des réunions de monitorage
IT / BCZS / ECZS	Canevas standardisés, DHIS2	DPS / PRONANUT	Mensuelle	Complétude et promptitude
DPS / PRONANUT	Bulletins, rapports consolidés	SNIS / DHIS2 national	Mensuelle	Cohérence inter-zonale
Responsable S&E/HMIS	Rapport mensuel, trimestriel, annuel	Chef de projet → UG-PDSS	Mensuelle à annuelle	Respect des échéances contractuelles
UG-PDSS / MSPHP	Rapports de performance	Bailleur et comité de pilotage	Trimestrielle	Atteinte des cibles

Boucle de rétroaction. TECH-4 insiste sur l'utilisation des données comme outil de gestion. Le plan institue trois retours systématiques : un feedback trimestriel écrit du Responsable S&E/HMIS vers chaque ECZS et chaque CAC, la restitution des Bulletins de Performance Communautaire aux assemblées villageoises, et la validation en revue de performance des plans de redressement issus du MAA.

8.5 Système d'information sanitaire

DHIS2 comme plateforme de référence. Le Système National d'Information Sanitaire de la RDC est bâti sur DHIS2 jusqu'au niveau de la zone de santé. TECH-4 relève toutefois que peu d'établissements y sont directement connectés, que la qualité des données n'est pas optimale et que la plateforme reste limitée au secteur public. Le projet agit sur ces trois limites : il dote 42 FOSA des aires de santé de Kikwit Nord et de Mosango d'un kit informatique, d'un kit solaire et d'un accès internet ; il forme les infirmiers titulaires au DHIS2 en milieu de travail ; il appuie les audits de qualité des données lors des sessions de MAA.

Intégration des données communautaires. TECH-4 identifie comme innovation l'intégration des données des activités communautaires dans DHIS 2.0, processus en cours au niveau national avec l'appui de SANRU. Le plan de S&E accompagne cette intégration : les indicateurs communautaires retenus (VAD, dépistage, référencement, supplémentation) sont définis de manière compatible avec les métadonnées nationales afin de pouvoir être saisis dans DHIS2 sans retraitement.

SNSAP. Le Système National de Surveillance Alimentaire et d'Alerte Précoce repose sur deux sites sentinelles par zone de santé, soit vingt sites pour les dix zones du projet. TECH-4 constate un dysfonctionnement de la transmission téléphonique faute de ressources et prévoit un forfait de crédit de 20 USD par mois et par zone de santé. Le plan suit la fonctionnalité de ces vingt sites comme indicateur d'extrant (P-18).

Dispositif numérique de terrain. Les RECO organisés en CAC reçoivent des tablettes électroniques pour le dénombrement de la population, la prestation de services communautaires et le suivi actif, longitudinal et personnalisé. Ce dispositif permet la surveillance à base communautaire digitalisée prévue par TECH-4 et alimente directement la base de suivi du consortium.

8.5.2 Architecture de la base de données de suivi

La base de suivi du consortium comporte cinq tables : (i) **référentiel** — zones de santé, aires de santé, villages, structures ; (ii) **indicateurs** — code, définition, unité, sens de progression, cibles annuelles et semestrielles ; (iii) **mesures** — valeur, période, désagrégation, source, date de saisie ; (iv) **qualité** — statut de vérification, écart entre sources, observations d'audit ; (v) **actions** — plan de redressement issu des revues. Cette architecture permet de produire automatiquement le tableau de bord du Cadre de performance.

8.5.3 Contrôle de la qualité des données

Tableau 11. Dimensions de la qualité des données et seuils retenus

Dimension	Définition opérationnelle	Seuil	Fréquence	Outil de vérification
Complétude	Proportion de rapports attendus effectivement saisis	≥ 90 %	Mensuelle	DHIS2, registre de transmission
Promptitude	Proportion de rapports saisis dans les délais	≥ 90 %	Mensuelle	Horodatage DHIS2
Cohérence	Absence d'écarts internes entre numérateur et dénominateur ou entre périodes	≤ 5 % d'écarts	Trimestrielle	Audit de cohérence
Exactitude	Concordance entre la donnée rapportée et la source primaire	≥ 90 %	Semestrielle	TPM, vérification inopinée
Actualité	Délai entre la fin de la période et la disponibilité de la donnée	≤ 30 jours	Mensuelle	DHIS2

Les résultats de ces contrôles ne sont pas archivés : ils sont restitués à chaque revue trimestrielle sous la forme d'une note de qualité des données par zone de santé, assortie, le cas échéant, d'un plan de redressement. Trois règles s'appliquent. Une zone dont la complétude ou la promptitude passe sous le seuil de 70 % fait l'objet d'un accompagnement rapproché du responsable S&E/HMIS. Un écart d'exactitude supérieur à 10 points entre les données de routine et le Third Party Monitoring déclenche un audit de la zone concernée. Enfin, aucun indicateur dont la donnée n'a pas été vérifiée n'est présenté comme atteint dans un rapport adressé à l'UG-PDSS : il est signalé comme « en attente de vérification », ce qui protège le consortium autant que le bailleur.

09

Système d'évaluation

Évaluation à mi-parcours, évaluation finale et évaluations thématiques

TECH-4 prévoit que les évaluations aient lieu à trois périodes clés : au début du programme, pour établir les niveaux de départ des indicateurs ; à mi-parcours, pour s'assurer du déroulement du processus ; à la fin, pour apprécier l'atteinte des objectifs et tirer les enseignements nécessaires. Le plan retient cette architecture et en précise les modalités.

9.1 Évaluation à mi-parcours — troisième trimestre 2027

Objet. L'évaluation à mi-parcours porte sur le processus de mise en œuvre et sur les premiers effets. Elle intervient après dix-huit mois environ de terrain, alors que les formations initiales sont achevées et que les formations sanitaires ont été dotées.

Objectifs

1. Apprécier le degré d'avancement vers les cibles de l'année 1 et expliquer les écarts observés.
2. Évaluer la qualité de la mise en œuvre du paquet NAC (formation, dotation, supervision, approvisionnement).
3. Vérifier la validité des hypothèses de la théorie du changement et identifier les goulots d'étranglement persistants.
4. Formuler des recommandations opérationnelles pour l'année 2 et proposer, le cas échéant, des réorientations.

Questions évaluatives

- Les activités communautaires atteignent-elles réellement les villages les plus éloignés et les populations les plus vulnérables ?
- Les enfants dépistés dans la communauté sont-ils effectivement pris en charge dans les formations sanitaires ? Où se rompt la chaîne de référencement ?
- Les formations réalisées ont-elles produit un changement de pratique observable au niveau des prestataires ?
- Les structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA) fonctionnent-elles conformément à leur mandat ?
- Le dispositif de suivi-évaluation produit-il des données suffisamment fiables pour piloter le projet ?
- Les mécanismes de prise en charge des survivantes de VBG sont-ils accessibles et confidentiels ?

Méthodologie

L'évaluation combine une **revue documentaire** (plan de travail, rapports périodiques, données DHIS2 auditées, rapports de supervision et de MAA), une **analyse quantitative** des 43 indicateurs avec comparaison référence / mi-parcours, des **enquêtes de terrain** dans un échantillon de zones de santé stratifié selon la couverture initiale en CAC (Kikwit Nord et Gungu, les plus en retard, contre Djuma et Kingandu, déjà à 100 %), des **entretiens semi-structurés** avec les ECZS, les prestataires, les CODESA et les autorités, et des **groupes de discussion** avec les mères et les RECO.

Livrables

- Note de cadrage et termes de référence détaillés (mois 6) ;
- Rapport provisoire présenté au comité de pilotage (mois 9) ;
- Rapport final d'évaluation à mi-parcours, incluant la matrice des recommandations (mois 10) ;
- Plan de réponse aux recommandations, validé et budgété pour l'année 2 (mois 10).

> **▶ Valeur d'usage de la mi-parcours**
> L'évaluation à mi-parcours n'est pas un exercice de conformité : elle intervient avant l'élaboration du plan de travail de l'année 2 et doit donc produire des arbitrages utilisables immédiatement. À cet effet, le rapport sera présenté à l'UG-PDSS avant la revue budgétaire annuelle.

9.2 Évaluation finale — quatrième trimestre 2028

Objet. L'évaluation finale apprécie l'atteinte des objectifs, la pertinence de la stratégie et les perspectives de durabilité. Conformément à TECH-4, elle ne traite pas de l'impact au sens strict : l'analyse de l'impact nécessiterait une étude plus approfondie que le mandat ne prévoit.

Critères d'évaluation (CAD de l'OCDE)

Tableau 12. Grille d'évaluation finale fondée sur les critères du CAD de l'OCDE

Critère	Question évaluative centrale	Éléments examinés	Méthode
Pertinence	Les objectifs et la stratégie du projet répondent-ils aux besoins nutritionnels réels des communautés des 10 ZS ?	Évolution du contexte, adéquation du paquet NAC, prise en compte du genre et des droits humains	Revue documentaire, entretiens, analyse des baselines
Cohérence	Le projet s'articule-t-il correctement avec le PMNS, le PNDS, le PRONANUT, les interventions du Fonds mondial et des autres partenaires ?	Alignement sur les politiques nationales, synergies, absence de duplication	Entretiens institutionnels, cartographie des intervenants
Efficacité	Dans quelle mesure les résultats attendus ont-ils été atteints ?	Taux d'atteinte des 43 indicateurs, effet par rapport aux cibles 2027 et 2028	Analyse quantitative, enquêtes, MAA
Efficience	Les ressources ont-elles été converties en résultats de manière économique et en temps utile ?	Coût unitaire par RECO formé, par FOSA dotée, par enfant traité ; délais de mise en œuvre	Analyse budgétaire, revue des marchés
Impact	Quels changements plus larges le projet a-t-il contribué à produire ?	Tendances du retard de croissance, de la MAG et de la mortalité ; effets non prévus	SMART, SNSAP, sources secondaires — analyse de contribution
Durabilité	Les acquis peuvent-ils se maintenir après le retrait du financement ?	Fonctionnalité des CAC et CODESA, plans d'action, financement basé sur la performance, appropriation par la DPS	Entretiens, observation, analyse institutionnelle

Livrables de l'évaluation finale

- Termes de référence de l'évaluation externe (annexe C) ;
- Rapport initial (méthodologie et échantillonnage) ;
- Rapport provisoire et séance de restitution aux parties prenantes ;
- Rapport final d'évaluation selon les critères OCDE-CAD ;
- Note de capitalisation : bonnes pratiques, innovations et leçons apprises ;
- Plan de durabilité et de transfert des acquis à la DPS et au PRONANUT.

9.3 Évaluations thématiques

TECH-4 prévoit plusieurs exercices spécifiques qui ne relèvent pas de l'évaluation globale mais éclairent des dimensions particulières du projet. Le plan les programme comme suit.

Tableau 13. Programmation des évaluations thématiques et des études

Objet	Approche	Échéance	Acteurs	Livrables
Qualité de la prise en charge de la malnutrition	Grille « Quality Health Scaling », auto-évaluation des centres nutritionnels	T2 2028 (puis semestriellement)	DPS, ECZS, consortium	Rapport de qualité des soins ; plan d'amélioration par FOSA
Prise en charge des VBG / EAS / HS	Revue de la qualité des services, accessibilité, confidentialité, délais de référencement	T4 2027	ONG spécialisée, sous-cluster VBG, PNSR	Rapport thématique ; cartographie actualisée des intervenants
Approche FARN et déviance positive	Étude de cas dans les 30 villages de Yasa Bonga et Kingandu	T3 2028	Consortium, ESP Kinshasa	Documentation de l'innovation ; conditions de mise à l'échelle
Recherche opérationnelle	Deux études protocolisées, soumises au comité d'éthique de l'ESP de Kinshasa	M5–M11 et M14–M20	Consortium, consultant recruté à cet effet	Protocoles, rapports de recherche, publications
Enquête de satisfaction des bénéficiaires	Enquête annuelle, complétée par les Bulletins de Performance Communautaire	T4 2027 et T4 2028	Consortium, CAC	Rapport de satisfaction ; plan de redressement

9.4 Utilisation des résultats

Toute évaluation produit un plan de réponse formel : chaque recommandation est affectée à un responsable, à une échéance et à une ressource. Le suivi de ce plan devient un point permanent de l'ordre du jour des revues trimestrielles, et le taux de mise en œuvre des recommandations constitue un indicateur de processus du Cadre de performance. Une recommandation non mise en œuvre au terme de deux revues est arbitrée par le comité de pilotage.

10

Redevabilité et apprentissage

Revues, coordination, capitalisation et gestion adaptative

10.1 Revues trimestrielles de performance

Huit revues trimestrielles sont programmées sur les vingt-quatre mois. Elles réunissent le chef de projet, le Responsable S&E/HMIS, les spécialistes techniques, les conseillers de zone et, selon l'ordre du jour, les ECZS concernées. Leur format est invariable, ce qui permet la comparaison d'une revue à l'autre.

Tableau 14. Ordre du jour type d'une revue trimestrielle de performance

Point	Contenu	Animation
1. Examen du tableau de bord	Positionnement des 12 KPI par rapport aux cibles semestrielles, code couleur vert / orange / rouge	Resp. S&E/HMIS
2. Analyse des goulots d'étranglement	Résultats du MAA du trimestre, causes identifiées par domaine (disponibilité, accessibilité, utilisation, qualité)	Conseillers de zone
3. Qualité des données	Complétude, promptitude, cohérence ; écarts TPM ; mesures correctives	Resp. S&E/HMIS, IT
4. Exécution du plan de travail	Taux de réalisation des activités, retards, contraintes	Chef de projet
5. Plan de redressement	Décisions, responsables, échéances, ressources ; suivi des décisions antérieures	Chef de projet

10.2 Réunions de coordination

TECH-4 prévoit plusieurs instances de coordination que le dispositif S&E alimente en données et en analyses.

Tableau 15. Instances de coordination et apport du dispositif S&E

Instance	Composition	Fréquence	Objet au regard du S&E
Comité de pilotage du consortium (CPP)	Représentants de chaque organisation membre	Trimestrielle	Orientations stratégiques, arbitrages, performance du consortium
Cadres de concertation post-mission	Comité de suivi de l'évaluation (DPS), consortium, partenaires	Après chaque mission de terrain	Présentation des observations et commentaires des participants
Revues semestrielles de la nutrition	Gouverneur, Ministre provincial de la Santé, DPS, PRONANUT, partenaires	Semestrielle	Réduction des goulots d'étranglement, couverture des interventions traceurs, mesures correctrices
Réunions de cluster Nutrition, WASH et Sécurité alimentaire	Partenaires sectoriels	Mensuelle à trimestrielle	Synergies, complémentarité des interventions, évitement des doublons
Réunions de monitorage des BCZS	ECZS, IT, AC, CODESA	Mensuelle	Analyse des données de routine, décisions locales

10.3 Capitalisation des leçons apprises

TECH-4 engage le consortium à documenter les bonnes pratiques, les innovations et les leçons apprises, en se concentrant sur ce qui fonctionne, où, pourquoi et pour qui. Le plan prévoit trois vecteurs :

- **Une fiche de leçon apprise par trimestre**, alimentée par le MAA et les revues, selon un canevas unique (contexte, constat, preuve, enseignement, recommandation, condition de transférabilité).
- **Deux notes de capitalisation thématiques** : l'une sur l'approche FARN et la déviance positive, l'autre sur la transformation des CAC en plateformes multisectorielles.
- **Un bulletin trimestriel de données clés** sur la nutrition, produit avec la DPS, qui diffuse les résultats du projet et les analyses du PRONANUT.

La diffusion s'adresse à trois audiences distinctes : les équipes du projet et les ECZS (notes internes), les partenaires et le bailleur (rapports et bulletins), les communautés (restitution orale en langues locales, appuyée sur les Bulletins de Performance Communautaire).

10.4 Gestion adaptative

La gestion adaptative est le mécanisme par lequel les constats du suivi et de l'évaluation se traduisent en décisions. Elle repose sur quatre règles simples :

1. **Un seuil déclenche une décision.** Tout indicateur passé en rouge lors d'une revue fait l'objet d'une analyse causale documentée et d'une mesure corrective affectée à un responsable nommé.
2. **Une décision a une échéance.** Aucune mesure corrective n'est adoptée sans date de revue de son exécution, inscrite à l'ordre du jour de la revue suivante.
3. **Le plan de travail est glissant.** Les enseignements du MAA et des revues alimentent une révision semestrielle du plan de travail, sans attendre la fin de l'année.
4. **Les réorientations majeures sont arbitrées au niveau du comité de pilotage**, sur la base d'une note technique du chef de projet appuyée par les données du S&E.

10.5 Redevabilité envers les communautés

TECH-4 fait de la redevabilité un principe directeur : les prestataires doivent être responsables envers les communautés qu'ils desservent, et les communautés doivent avoir la capacité d'exiger des services de qualité. Deux instruments opérationnalisent ce principe.

- **Le Bulletin de Performance Communautaire (BCP)**, systématisé dans le fonctionnement de routine des CAC : les communautés évaluent la qualité des prestations qui leur sont offertes et établissent avec le prestataire un plan commun de redressement.
- **Le mécanisme de gestion des plaintes**, porté par un comité dans chaque village, adossé à la ligne verte et à un registre de plaintes, avec des garanties de confidentialité et de non-représailles. Les plaintes sensibles liées à l'exploitation et aux abus sexuels suivent une procédure spécifique, conformément aux outils de la Banque mondiale cités par TECH-4.

11

Budget du suivi-évaluation

Enveloppe, répartition par activité et règles de gestion

TECH-4 ne comporte aucune ligne budgétaire chiffrée : ni le montant total du marché, ni la ventilation par composante n'y figurent. Le plan retient donc la règle de dimensionnement appliquée aux projets financés par des bailleurs internationaux — une enveloppe de suivi-évaluation représentant **7 % du budget total** — et en propose la répartition par activité.

> ⚠ **Assiette budgétaire : donnée manquante à Tech-4**
> Montant total du marché et budget par composante : [À compléter selon Tech-4]. Le taux de 7 % retenu se situe dans la fourchette de 5 à 10 % recommandée ; il sera confirmé par l'UG-PDSS lors de la revue de démarrage.

11.1 Enveloppe et répartition par activité

Tableau 16. Répartition de l'enveloppe de suivi-évaluation par activité (7 % du budget du projet)

N°	Poste	Contenu	Part de l'enveloppe S&E	Répartition indicative par année
1	Ressources humaines du S&E	Responsable S&E/HMIS (100 %), chargé de données, appui du responsable IT, conseillers de zone pour la partie suivi	28 %	Y1 : 30 % — Y2 : 26 %
2	Enquête de référence	Enquêtes SMART, CAP, fonctionnalité des structures communautaires, dénombrement actualisé	12 %	Y1 : 100 %
3	Collecte de routine et digitalisation	Tablettes, forfaits de connectivité, impression des canevas et registres, maintenance	10 %	Y1 : 50 % — Y2 : 50 %
4	Monitorage Amélioré pour l'Action et audits de qualité des données	Organisation de 40 sessions de MAA par an, grilles d'audit, ateliers de restitution	8 %	Y1 : 50 % — Y2 : 50 %
5	Third Party Monitoring indépendant	Quatre missions de vérification indépendante, contrats avec un opérateur externe	9 %	Y1 : 45 % — Y2 : 55 %
6	Évaluation à mi-parcours	Équipe d'évaluation, enquêtes de terrain, atelier de restitution	7 %	Y1 : 100 %
7	Évaluation finale externe	Équipe d'évaluation, enquêtes, analyse selon les critères OCDE-CAD, atelier national	9 %	Y2 : 100 %
8	Évaluations thématiques et recherche opérationnelle	Qualité des soins, VBG, FARN, deux études protocolisées et soumises au comité d'éthique	6 %	Y1 : 40 % — Y2 : 60 %
9	Revues, bulletins et rapports	Huit revues trimestrielles, quatre revues semestrielles, bulletins trimestriels, rapports à l'UG-PDSS	6 %	Y1 : 50 % — Y2 : 50 %
10	Capitalisation et documentation	Fiches de leçons apprises, notes de capitalisation, publication et diffusion	3 %	Y1 : 40 % — Y2 : 60 %
11	Renforcement des capacités S&E des partenaires	Formation des ECZS et des IT à l'analyse et à l'utilisation des données	2 %	Y1 : 60 % — Y2 : 40 %

Les montants absolus seront obtenus en appliquant 7 % à l'assiette contractuelle : les évaluations externes représentent 16 % de l'enveloppe, les opérations de mesure 39 %, les ressources humaines 28 %.

11.2 Règles de gestion

- **Engagement budgétaire annuel.** L'enveloppe S&E est engagée par exercice, avec un taux d'exécution cible de 90 % en fin d'année ; un écart supérieur à 15 points déclenche une revue budgétaire.
- **Non-substituabilité.** Les crédits du S&E ne peuvent être redéployés vers les activités programmatiques qu'après autorisation écrite de l'UG-PDSS.
- **Traçabilité et audit.** Chaque dépense est rattachée à une activité du présent plan et à un livrable identifié (rapport, évaluation, bulletin) ; les dépenses de S&E sont auditées annuellement dans le cadre de l'audit du projet.

12

Annexes

Fiches techniques d'indicateurs, modèles de rapports et termes de référence types

Annexe A — Fiches techniques d'indicateurs

Les fiches ci-dessous détaillent, à titre de modèle, cinq indicateurs parmi les quarante-trois du plan. Chaque fiche est destinée à être reproduite pour l'ensemble des indicateurs et intégrée à la base de suivi du consortium.

Fiche R-01 — Taux de prise en charge des enfants MAS référés dans les UNTA/UNTI

Champ	Contenu
Code	R-01
Libellé	Taux de prise en charge des enfants MAS référés dans les UNTA/UNTI
Définition	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois référés pour malnutrition aiguë sévère qui sont admis et traités conformément au protocole national de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë.
Num / Dén	Enfants MAS référés et admis dans une UNTA ou une UNTI / Enfants MAS référés par les RECO ou dépistés en FOSA
Valeur de référence	n.d. — à établir par l'enquête de référence
Cibles	≥ 80 % en 2027 et en 2028
Source et outil	Registres UNTA/UNTI, fiches de référence, DHIS2, vérification lors du MAA
Fréquence	Trimestrielle
Responsable	Spécialiste Nutrition
Contrôle qualité	Contrôle croisé entre le nombre de fiches de référence émises et le nombre d'admissions enregistrées ; vérification inopinée d'un échantillon de dix dossiers par FOSA et par trimestre.

Fiche R-03 — Taux d'allaitement maternel exclusif chez les enfants de 0–5 mois

Champ	Contenu
Code	R-03
Libellé	Taux d'allaitement maternel exclusif chez les enfants de 0–5 mois
Définition	Proportion d'enfants de 0 à 5 mois nourris exclusivement au sein au cours des 24 heures précédant l'enquête, sans autre liquide ni aliment, à l'exception de sels de réhydratation orale, de gouttes ou de sirops de vitamines, de minéraux ou de médicaments.
Num / Dén	Enfants de 0–5 mois allaités exclusivement / Enfants de 0–5 mois vivants
Valeur de référence	32,7 % (MICS-Palu 2017-2018)
Cibles	43 % en 2027 ; 53,5 % en 2028 (alignement national)
Source et outil	Enquête CAP, enquête SMART, DHIS2 (CPoN), MAA
Fréquence	Annuelle
Responsable	Resp. S&E/HMIS
Contrôle qualité	Formation des enquêteurs aux définitions standard ; supervision de 10 % des entretiens ; contrôle de cohérence avec les données de CPoN.

Fiche R-10 — Proportion de survivantes de VBG ayant bénéficié d'une prise en charge holistique

Champ	Contenu
Code	R-10
Libellé	Proportion de survivantes de VBG ayant bénéficié d'une prise en charge holistique
Définition	Proportion de survivantes de violences basées sur le genre déclarées qui ont accédé à au moins deux des trois composantes de la prise en charge holistique : médicale, psychosociale et juridique.
Num / Dén	Survivantes ayant accédé à une PEC holistique / Survivantes déclarées et enregistrées
Valeur de référence	1,9 % (troisième trimestre 2021)
Cibles	25 % en 2027 ; ≥ 50 % en 2028
Source et outil	DHIS2, registres VBG des FOSA, rapports de l'ONG spécialisée, sous-cluster VBG

Champ	Contenu
Fréquence	Trimestrielle
Responsable	Spécialiste engagement communautaire / genre
Contrôle qualité	Vérification de la confidentialité des registres ; contrôle du respect du délai de 72 heures pour la prise en charge médicale ; analyse des perdus de vue.

Fiche P-01 — Nombre de RECO formés au paquet NAC

Champ	Contenu
Code	P-01
Libellé	Nombre de RECO formés au paquet NAC
Définition	Nombre cumulé de relais communautaires ayant achevé la formation initiale ou le recyclage au paquet NAC (ANJE, PCIMA, CPSr, PFE, SDE, VBG, gestion des données, gestion des déchets).
Num / Dén	RECO ayant achevé la formation avec attestation / cible totale de 8 314 RECO
Valeur de référence	0 — dernière formation dans la seule ZS de Mosango, il y a quatre ans
Cibles	4 956 en 2027 ; 8 314 en 2028
Source et outil	Fiches de présence, attestations, base de données des ressources humaines communautaires
Fréquence	Trimestrielle
Responsable	Spécialiste Nutrition
Contrôle qualité	Contrôle de la concordance entre fiches de présence, attestations et paiement des perdiem ; suivi post-formation à trois mois pour vérifier les acquis.

Fiche X-03 — Taux de complétude et de promptitude des données DHIS2 des 10 zones de santé

Champ	Contenu
Code	X-03
Libellé	Taux de complétude et de promptitude des données DHIS2 des 10 zones de santé
Définition	Proportion de rapports mensuels attendus effectivement saisis et validés dans DHIS2 dans le délai contractuel, pour les dix zones de santé du projet.
Num / Dén	Rapports saisis et validés à temps / Rapports mensuels attendus
Valeur de référence	n.d. — cinq ZS « silencieuses » en 2021 (Kikwit Nord, Kimputu, Kingandu, Moanza, Pay Kongila, Yasa Bonga)
Cibles	80 % en 2027 ; ≥ 90 % en 2028
Source et outil	DHIS2 (horodatage), registre de transmission, rapports d'audit de qualité des données
Fréquence	Mensuelle
Responsable	Resp. S&E/HMIS
Contrôle qualité	Extraction mensuelle automatisée ; rappel aux zones en retard ; audit trimestriel de cohérence ; vérification croisée avec le TPM.

Annexe B — Modèles de rapports

Trois modèles de rapports structurent la production périodique du consortium. Leur format est aligné sur les attentes de l'UG-PDSS rappelées par TECH-4 : rapports d'avancement mensuels, trimestriels et annuels.

Tableau 17. Modèles de rapports et canevas

Rapport	Émetteur	Échéance	Structure type
Rapport mensuel d'activités	Responsable S&E/HMIS	Le 5 du mois suivant	1. Faits saillants du mois (10 lignes maximum) 2. Avancement des activités par résultat intermédiaire 3. Tableau des indicateurs mensuels et taux de complétude 4. Difficultés et goulots d'étranglement 5. Mesures correctives et responsables 6. Annexes : canevas de collecte, liste des sites visités
Rapport trimestriel de performance	Chef de projet et Responsable S&E/HMIS	Le 15 du mois suivant le trimestre	1. Synthèse de performance et code couleur des KPI 2. Analyse par objectif spécifique 3. Résultats du MAA et des audits de qualité des données 4. Exécution du plan de travail et du budget 5. Suivi des recommandations antérieures 6. Plan de redressement du trimestre suivant
Rapport annuel	Chef de projet	Le 31 janvier de l'année suivante	1. Bilan de l'année au regard du cadre logique 2. Atteinte des 43 indicateurs et comparaison aux cibles 3. Analyse des écarts et facteurs explicatifs 4. Leçons apprises et bonnes pratiques 5. Exécution budgétaire 6. Perspectives et plan de travail de l'année suivante
Rapport d'évaluation (mi-parcours / finale)	Équipe d'évaluation externe	Selon termes de référence	1. Résumé exécutif 2. Contexte et objet de l'évaluation 3. Méthodologie et limites 4. Constats par critère ou par question évaluative 5. Conclusions 6. Recommandations hiérarchisées 7. Annexes : outils, liste des personnes rencontrées, données

Annexe C — Termes de référence types

C.1 Termes de référence — évaluation à mi-parcours (T3 2027)

Rubrique	Contenu
Contexte	Le consortium SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS met en œuvre, dans dix zones de santé de la province du Kwilu, les services de nutrition à assise communautaire du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé. L'évaluation à mi-parcours intervient après dix-huit mois de mise en œuvre.
Objet	Apprécier le degré d'avancement vers les cibles de l'année 1, la qualité de la mise en œuvre et la validité des hypothèses de la théorie du changement, et formuler des recommandations pour l'année 2.
Questions évaluatives	Cinq à sept questions portant sur la couverture, la qualité, la continuité communauté–FOSA, la fonctionnalité des structures communautaires et la fiabilité du dispositif de S&E.
Méthodologie attendue	Revue documentaire ; analyse quantitative des 43 indicateurs ; enquêtes de terrain dans quatre zones de santé contrastées ; entretiens semi-structurés ; groupes de discussion.
Profil de l'équipe	Chef de mission expert en santé publique et nutrition (10 ans d'expérience minimum) ; expert en suivi-évaluation ; expert en genre et protection ; enquêteurs formés.
Durée et lieu	45 jours calendaires, dont 20 jours de terrain dans la province du Kwilu.
Livrables	Note de cadrage, rapport provisoire, rapport final, matrice des recommandations, présentation de restitution.
Critères d'évaluation des offres	Compréhension du mandat (20 %), qualité de la méthodologie (30 %), expérience de l'équipe (30 %), offre financière (20 %).

C.2 Termes de référence — évaluation finale (T4 2028)

Rubrique	Contenu
Contexte	Fin de la période de mise en œuvre du projet dans les dix zones de santé du Kwilu.
Objet	Apprécier l'atteinte des objectifs et analyser la performance du projet selon les six critères du CAD de l'OCDE : pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité.
Questions évaluatives	Une à deux questions par critère, formulées dans la note de cadrage, avec indication des éléments de preuve attendus.
Méthodologie attendue	Analyse quantitative des quarante-trois indicateurs sur les deux années ; comparaison référence / mi-parcours / finale ; enquête de terrain ; analyse budgétaire et de coût-efficacité ; analyse institutionnelle de la durabilité.
Profil de l'équipe	Chef de mission senior (15 ans d'expérience), expert en évaluation, expert en analyse économique, expert en genre.
Durée et lieu	60 jours calendaires, dont 25 jours de terrain.
Livrables	Rapport initial, rapport provisoire, rapport final, note de capitalisation, plan de durabilité et de transfert des acquis.
Exclusion explicite	Conformément à TECH-4, l'évaluation finale n'analyse pas l'impact au sens strict : elle en propose une lecture en termes de contribution, appuyée sur les tendances du retard de croissance et de la malnutrition aiguë.

Fin du Plan de Suivi-Évaluation 2027-2028. Document établi sur la base exclusive du formulaire TECH-4 (DP N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS). Les données absentes du document source sont signalées par la mention « [À compléter selon Tech-4] ».